

Libre de Ansiedad

Con compromiso, disciplina y acción constante, podemos vencer la ansiedad y alcanzar la paz interior que merecemos. ¡Nada nos detendrá en nuestro camino hacia la felicidad y el bienestar emocional!

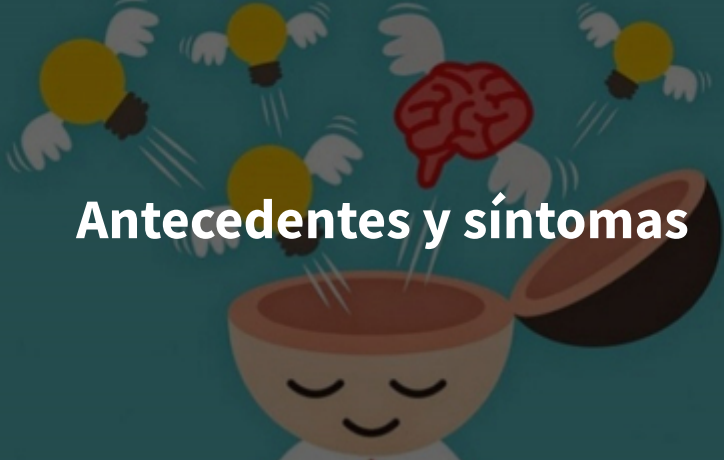


Superemos juntos la Ansiedad

“La habilidad de adaptarse al cambio requiere de acompañamiento para reconocer y controlar las emociones”

Citas conmigo

““La buena vida es un proceso, no un estado del ser. Es una dirección, no un destino”. (Carl Rogers)”

An illustration at the top of the page shows a smiling bowl with its lid open. Inside the bowl is a red brain. Several yellow lightbulbs are floating above the bowl, with lines indicating they are being pulled towards it. The background is a dark teal color.

Antecedentes y síntomas

Los individuos en alto riesgo (Canadian Psychiatric Association, 2006; Michael y cols., 2007).son aquellos, que presentan:

Insomnio o fatiga crónica.

Antecedentes heredofamiliares de ansiedad con algún trastorno psiquiátrico.

Tendencia a la inhibición conductual. Se refiere a la tendencia temperamental de reaccionar con inhibición ante situaciones novedosas o amenazantes; tales como la timidez,o la evitación de situaciones novedosas (Cloninger 2000; Cloninger y cols., 1993).

Antecedentes de haber padecido durante la adolescencia o la niñez intranquilidad y preocupaciones constantes.

Antecedentes de vivir o haber vivido bajo estresores (laborales, económicos, sociales, etcétera).

Antecedentes de vivir o haber padecido eventos traumáticos y/o abuso (sexual, marital, familiar, verbal, físico, etcétera)

Sexo femenino (desregulación hormonal, trastornos endocrinos o ginecológicos) (a excepción del TOC).

Diagnóstico psiquiátrico, particularmente depresión y las adicciones

Tipos de Ansiedad

1. Fobia Simple y Social

sin tiempo mínimo



Fobia Simple

Temor y/o síntomas desencadenados por la presencia o anticipación de estímulo fóbico



Fobia Social

Temor y/o síntomas ansiosos desencadenados por la exposición al escrutinio social con preocupación de que el desempeño pueda ser causa de humillación o burla.

2. Trastorno de Pánico (TP)

Mínimo 1 mes

- Ataques de pánico (AP) súbitos, inesperados y recurrentes.
- Ansiedad anticipatoria
- Preocupación constante por las repercusiones de los AP
- Cambios significativos en la conducta habitual relacionado con los AP



3. Ansiedad generalizada

Mínimo 6 meses

La mayoría de los días con preocupaciones y nerviosismos excesivos , cuya intensidad han debilitado el control sobre ellos.

- Intranquilidad
- Fatigabilidad
- Concentración
- Irritabilidad
- Tensión Muscular
- Alteración en el dormir (insomnio o sueño insatisfactorio)

4. Trastorno obsesivo compulsivo

Sin tiempo mínimo

Presencia de obsesiones y/o compulsiones



Pensamientos, imágenes o impulsos

- Intrusivos , Repetitivos, inapropiados, Ansiogénicos, considerados como producto de su propiamente.



- El sujeto tiene la necesidad de suprimirles , neutralizarles o controlarles mediante otro pensamiento o la ejecución de alguna opción.
- Preocupaciones o ideas delirantes.



Conductas

- lavado de manos, ordenar, revisar,
- rezar, contar, repetir palabras mentalmente, etcétera



El sujeto se percibe con la necesidad imperiosa de llevarlas a cabo

5. Trastorno por estrés post-traumático



Antecedente de exposición a situación traumática (abuso, asalto, secuestro, etcétera)

- Recuerdos intrusivos recurrentes
- Sueños estresantes recurrentes
- Flashbacks: comportarse o tener la sensación de que el evento está volviendo a ocurrir
- Temor, ansiedad o reacciones neurovegetativas al exponerse a situaciones o a objetos relacionados con el evento.

¿Qué es un Ataque de pánico?

Según la teoría Biofisiosocial de Barlow (1988), **el ataque de pánico** inicial es pensado como una falla del sistema de alarma bajo circunstancias estresantes, y cierta **vulnerabilidad tanto fisiológica como psicológica**. La **vulnerabilidad fisiológica** hace referencia a un sistema autonómico lábil o hipersensible y la vulnerabilidad psicológica se relaciona con las creencias sobre **“lo peligroso”** de las sensaciones físicas y del mundo en general.

Existe también una predisposición familiar a padecer este trastorno, en parte es hereditaria y a su vez está relacionada con el aprendizaje de modelos parentales.

El estrés (**físico, emocional, mental**) suele ser el antecedente frecuente del **primer ataque de pánico**. Las repetidas situaciones de estrés van activando crónicamente al sistema nervioso. En general, la persona supone que su primera crisis ha ocurrido sin un factor desencadenante (cuando aparentemente todo está en calma). **Durante la crisis, la reacción física es similar a la que ocurriría frente a un peligro real**, con la diferencia, que es activada en ausencia de una amenaza concreta.

Posterior al ataque, lo que se siente es un gran agotamiento psicofísico acompañado del temor de volver a sentirse mal (**miedo al miedo**) y al no encontrar una explicación válida a su aparición, lo que se piensa sobre las **sensaciones de pánico** toma un papel fundamental.

Se produce entonces un **cambio en la conducta habitual** de quien padece pánico. **Cuando las crisis se repiten**, la persona deja de actuar como antes, **está hipervigilante, no descansa, pierde seguridad y comienza a evitar situaciones o lugares** en los que tuvo síntomas de pánico.

¿Qué es el trastorno de pánico con agorafobia?:

Cuando la asociación entre las sensaciones internas y la interpretación negativa se suma a determinadas situaciones externas se produce la **agorafobia**. Se empieza a temer por ejemplo, ir al supermercado, a lugares concurridos, a realizar actividad física, a viajar en diferentes medios de transporte, incluso hasta prácticamente no salir de su casa por **temor a exponerse a situaciones que generen nuevas crisis**.

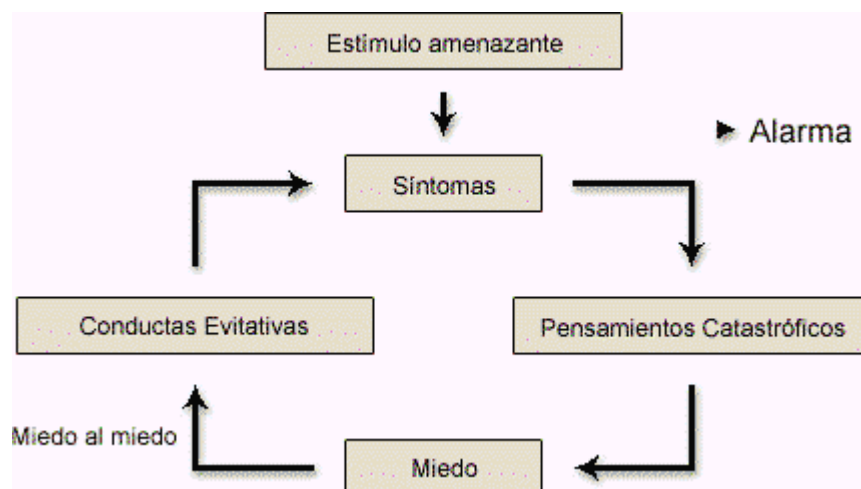
Es común comenzar a utilizar conductas u objetos de reaseguro como por ejemplo salir acompañado, llevar consigo medicamentos, botellitas de agua, teléfonos de emergencia, o al conducir el auto se maneje por el carril derecho para poder parar o desviarse. También ir al cine sentándose cerca de la puerta de salida, a un shopping u otro lugar concurrido conocer donde están los baños y las salidas.

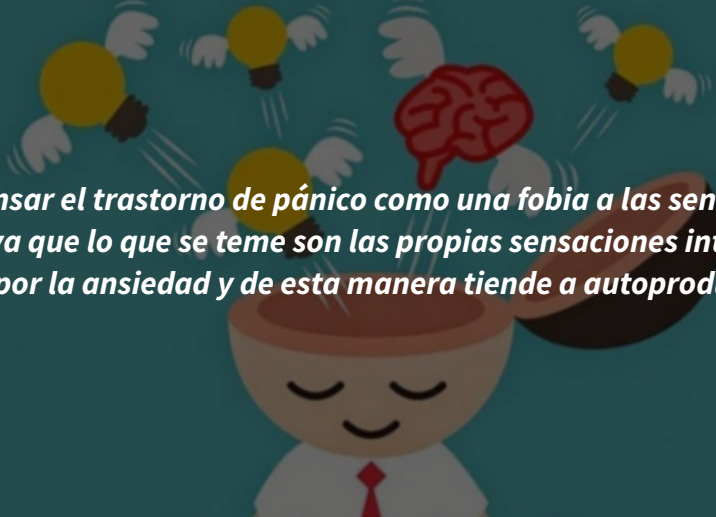
Por último, los datos en relación a la prevalencia indican:

- Una de cada diez personas tiene una crisis de pánico a lo largo de su vida.
- Una de cada treinta personas padece la enfermedad (entre el 2 y el 5% de la población general).
- La edad de comienzo típica es entre los 25 y 30 años y 3 de cada 4 afectados son mujeres.
- Suele variar la forma en que evoluciona, tiende a ser una enfermedad de curso fluctuante y crónico.

Luego del primer ataque se tiende a vivir en un estado de alerta constante lo que favorece que frente a la mínima sensación corporal aumente la posibilidad de una nueva crisis, ya que hay una interpretación catastrófica de dichas sensaciones.

Circuito del Pánico:





Podemos pensar el trastorno de pánico como una fobia a las sensaciones corporales, ya que lo que se teme son las propias sensaciones internas que se intensifican por la ansiedad y de esta manera tiende a autoproducirse.

¿Qué es la despersonalización o desrealización?

Es una sensación persistente o repetitiva de separación del propio cuerpo o de los propios procesos mentales, como un observador externo de la vida (despersonalización) y/o como sentirse totalmente desconectado del entorno que le rodea a uno (desrealización). Estos tipos de síntomas pueden aparecer cuando tenemos dificultades con el sueño.

Para ello es importante tener una buena Higiene del Sueño y controlar síntomas

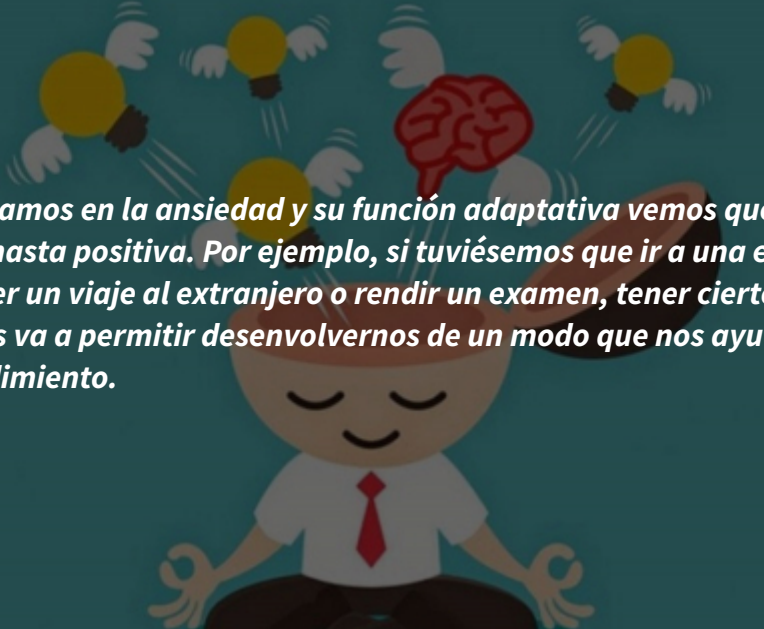
Explicación de los síntomas

¿A qué se deben las sensaciones físicas?

Si su **cerebro percibe una situación de riesgo** (real o imaginaria) activará un sistema de alarma que dará lugar a cambios a nivel fisiológico para proteger su vida. Estos cambios en el **ataque de pánico se viven como una amenaza ya que el peligro no es real**, si realmente estuviera frente a una situación de riesgo estos síntomas no los sentiría como peligrosos para usted.

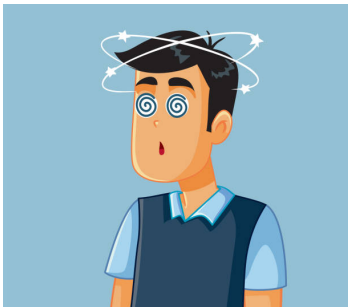
Por ejemplo, si en este momento estuviera en un lugar que comienza a incendiarse, percibirá el peligro y se activará su sistema de alarma dando lugar a la activación fisiológica, permitiendo así que salga corriendo del lugar y preserve su vida. **Necesitará que su corazón lata más rápido para enviar más sangre a sus extremidades** y esto no será interpretado como peligroso, sino todo lo contrario.

A continuación se detallan los principales síntomas de pánico y la interpretación distorsionada de los mismos:



Pero, si pensamos en la ansiedad y su función adaptativa vemos que es muy necesaria y hasta positiva. Por ejemplo, si tuviésemos que ir a una entrevista laboral, hacer un viaje al extranjero o rendir un examen, tener cierto grado de ansiedad nos va a permitir desenvolvernos de un modo que nos ayude a mejorar nuestro rendimiento.

Real explicación de los síntomas



Mareo

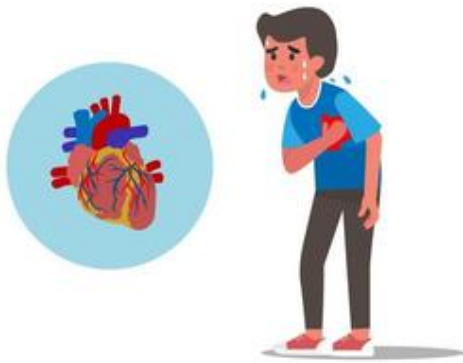
Tensión de cervicales que disminuye el aporte de sangre a la cabeza. Efectos diversos de la hiperventilación. Presión arterial baja de origen diverso (por ejemplo: efecto secundario de la medicación)

Falta de aire

Aumento de oxígeno en la sangre debido a la hiperventilación (que es lo contrario a la asfixia)

Es común pensar, **“me voy a asfixiar”, “no puedo respirar, me ahogo”**. La experiencia clínica muestra que nadie ha muerto de asfixia u ahogo durante una crisis de pánico, por el contrario, aumenta el oxígeno en la sangre como resultado de la **hiperventilación**.



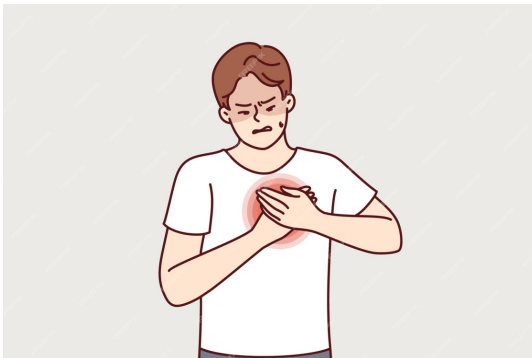
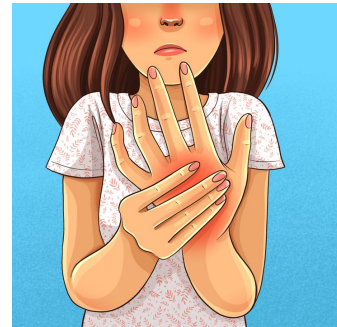


Taquicardia, palpitaciones

Cuando estamos en peligro, real o imaginario, el corazón trabaja con mayor fuerza y rapidez. así envía más sangre a las zonas implicadas en la reacción de alarma, para que puedan funcionar más eficazmente, eliminar mejor las toxinas, y así prepararnos para el **ataque o la huida**.

Hormigueo en las extremidades, pérdida de sensibilidad, palidez

“Me siento muy débil” “siento que me acalambro”, “se me durmieron las manos”. La afluencia de sangre es mayor en los lugares donde puede ser más necesaria, dejando al resto del cuerpo con un riesgo menor. De este modo, si fueses herido sería menos propenso a desangrarte



Opresión, dolor o pinchazos en el pecho. Dolor en brazo izquierdo

Tensión de los músculos intercostales debida a la hiperventilación o a mantener los pulmones demasiado llenos de aire. Contracturas en cervicales o dorsales que irradian el dolor a esas zonas. Posturas corporales incorrectas habituales.

Calor, sofoco, sudor, escalofríos

Aumento de la temperatura en las zonas corporales más vitales y puestas en marcha del sistema de enfriamiento de nuestro organismo (sudor)



¿crees que te estás
volviendo
loco?



**Percibir las cosas de manera extraña o inusual,
ver "lucecitas"**

*"Me estoy volviendo loco", el tener sensaciones extrañas y el sentimiento de estar perdiendo el control suele ocurrir en todas las personas. Esto es diferente a la **pérdida de contacto con la realidad a largo plazo**. Disminución de oxígeno en ciertas zonas del cerebro, debido a la hiperventilación. **Dilatación de las pupilas** que aumenta la visión periférica facilitando así la percepción de posibles peligros.*

Temblor, pinchazos, parestesias

"Algo no está bien". Se debe al exceso de tensión muscular.



Dificultad para pensar en la forma habitual

Cuando sentimos una emoción muy intensa, como el pánico, la ira, etc; se produce un "secuestro emocional", que nos causa una dificultad transitoria para pensar y actuar en la forma en la que habitualmente lo hacemos. Esa es la forma normal en que funciona nuestra mente y es útil cuando enfrentamos una situación de peligro real.

Nauseas o molestias abdominales

"Voy a vomitar", "me descompongo". Efectos normales de la ansiedad en el sistema digestivo. No suponen ningún peligro y mejoran en cuanto se reduce la ansiedad.



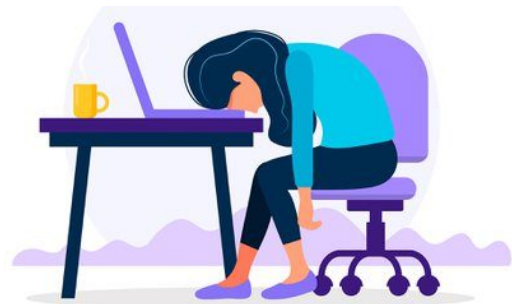


Opresión o sensaciones extrañas en la cabeza

Disminución de oxígeno en ciertas áreas del cerebro. Contractura de cervicales que dificulta la irrigación sanguínea de la cabeza y que produce diversas molestias.

Cansancio, Agotamiento

Mantenimiento de los músculos estirados y tensos durante mucho tiempo. Falta de sueño profundo y reparador.



Cualquier sensación interna temida

La focalización de la atención en captarlas, aumenta la percepción de cualquier sensación (puedes comprobarlo). Además, dado que las sensaciones temidas en el pánico son las propias de la ansiedad, cualquier pensamiento de que suponen un peligro, puede producirlas o incrementarlas.

Focalizar la atención en cualquiera de estas sensaciones solo aumentará la percepción de las mismas, provocando mayor ansiedad.

EJERCICIO

Vamos a tomar un cuaderno, una agenda, o una hoja y la vamos a dividir en dos partes, como te muestro en el ejemplo. Y vamos a empezar a rellenar todos los síntomas que tienes.

EJEMPLO:

	SINTOMAS QUE ME GENERAN MÁS MALESTAR DE (- A +) EJEMPLO:	TUS SINTOMAS....
1.	Aceleración Cardíaca	
2.	Sudoración	
3.	Presión en el pecho	
4.	Sensación de ahogo	
5.	Temblor	

En la siguiente tabla se muestra un registro el cual debe ser llenado **con 4 peores momentos de ansiedad**, esto nos ayudará a conocer mejor su problema y nos permitirá intervenir de mejor manera. **La primera fila se muestra un EJEMPLO de cómo se llenará el registro, por favor tómelo de guía.** Recuerde que todo se rige bajo el principio de la confidencialidad, lo que quiere decir que nada de lo que se trabaje en el registro se dará a conocer a personas ajenas al proceso terapéutico.

EJEMPLO:

Fecha y hora aproximada.	Situación <i>¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué produjo mi malestar emocional?</i>	Pensamiento <i>(En que pensé, que ideas dieron vueltas por mi cabeza en el momento del malestar emocional)</i>	Físico <i>(Que sentí en mi cuerpo)</i>	Que hice <i>(Como reaccioné)</i>	Emoción <i>(¿Que emoción experimenté? Tristeza, rabia, miedo, alegría)</i>	Que pasó después
8:00 am Lunes 15 de enero	Me desperté, había dormido mal por discusiones con mi pareja	Me puede dar de nuevo ansiedad porque no dormí, me puede dar un episodio de pánico, me voy a morir	Aceleración cardíaca, falta de aire, tensión muscular, sudoración temblor	Llame a mi pareja para que el pidiera una ambulancia	Miedo y rabia	Llegaron los paramédicos me tomaron la presión y ya estaba bien, me llevaron al hospital me examinaron y estaba mi corazón bien

Actividad rellenable word

BLOG

Entradas que te pueden interesar.



Síntomas de los ataques de pánico

Los ansiosos se preguntan si una taquicardia puede implicar una enfermedad cardíaca, o si un mareo puede implicar un problema neurológico, como un derrame cerebral. Para tranquilidad de ellos les reitero en este vídeo que solo se trata de ansiedad. Que uno de los principales síntomas es precisamente «Preocupación excesiva por sufrir una enfermedad grave o muerte».



Trastorno de ansiedad social ¿Qué es? Ejercicios para curarlo

El día de hoy te daré a conocer ciertos parámetros que son indicadores del padecimiento del trastorno de ansiedad, de esta manera si te sientes identificado con dichos factores te invito a que mires mi video para poder ayudarte a superar esto.



Qué es la Ansiedad y sus Tipos

Mucha gente todavía **no** tiene **claro** que esos son los **síntomas básicos** de la **ansiedad**.

Es por eso que en este video retomo los conceptos más básicos de la Ansiedad, es decir cuáles son los síntomas, sus características y los sub tipos (divisiones) de la Ansiedad.



¿Cómo saber si tengo ataques de pánico?

A través de los casos de Darío y de Camilo vamos a saber cuáles son los síntomas de un ataque de pánico. A través de un ejercicio didáctico tú vas a encontrar cuál de ellos lo padece.



¿Qué es la ansiedad generalizada?

En este video te explico que es la Ansiedad Generalizada, cuáles son sus síntomas y como se puede superar.

Analizaremos que no solo basta con cumplir algunos síntomas físicos sino que también deben estar presentes ciertos tipos de pensamientos.



Ataques de pánico, 7 pasos para superarlos en poco tiempo

En el video de esta semana se muestran **7 pasos** con los cuales podrás **superar un ataque de pánico, en poco tiempo**



¿Por qué tengo ataques de pánico?

Después de mirar este Video vas a poder identificar las razones por las cuales tienes ataques de pánico (Crisis de ansiedad – Crisis de Angustia). Vas a poder identificar los estresores, es decir las situaciones, personas, o eventos, que se fueron acumulando hasta que al fin “erupcionan” en forma de ataque de pánico.



Ansiedad y Zumbidos en los oídos ¿Qué hacer?

En el vídeo de esta semana te explico cuales son las razones por las cuales algunas personas ansiosas comienzan a sentir pitidos o zumbidos en sus oídos.



Que es la Agorafobia y como superarla

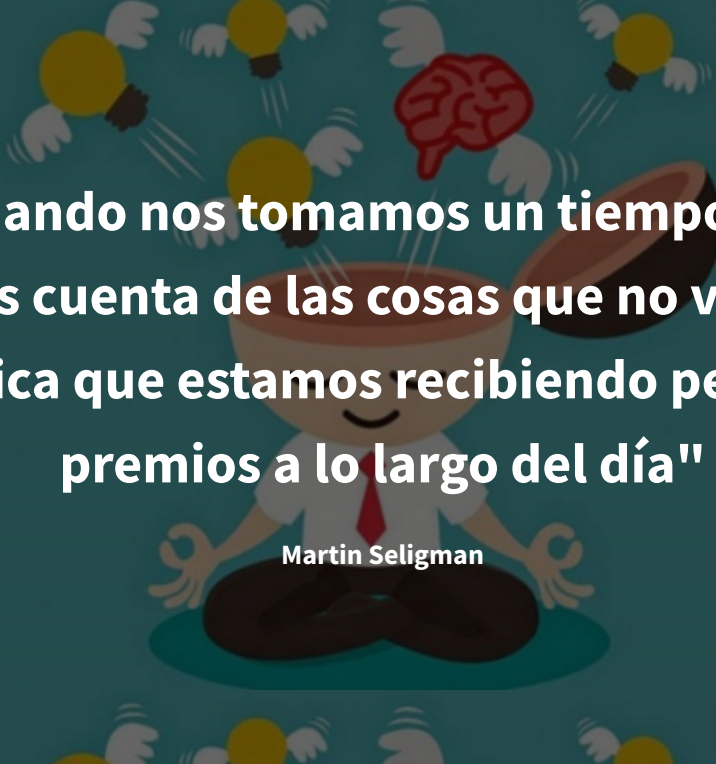
En este video te explicamos en que consiste la agorafobia y como se puede superar, para ello hemos invitado a Ruben Casado y a Cristina Luna, los dos psicólogos especialistas en la ansiedad, trabajan en la Asociación Madrileña para la Ansiedad y la Agorafobia (**AMADAG**).



¿Qué es el TOC y cómo curarlo?

Hoy te hablo sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo TOC. Te explicaré en detalle cuando lo padecemos y cuándo no, cuándo es algo crónico que afecta nuestra vida y cuando es algo pasajero.

SITIO WEB

An illustration of a person with a large head, wearing a white shirt and a red tie, sitting in a meditative lotus position. Above their head is a red brain, and several yellow lightbulbs are floating around it, some with motion lines indicating they are being tossed or are glowing. The background is a dark teal color.

"Cuando nos tomamos un tiempo para darnos cuenta de las cosas que no van bien, significa que estamos recibiendo pequeños premios a lo largo del día"

Martin Seligman

¡Atrévete a Hacer cambios en tu vida!

Página 16



Nelson Arturo Psicologo

Cr 40 A no 20 - 55, Pasto
Colombia

+573117606107
info@nelsonarturopsicologo.com